



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25911741

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 浅表躯体肿块



检查所见:

双侧面部自诉肿块处扫查: 右侧腮腺旁可见数枚低回声结节, 互相融合, 呈藕节状, 范围约3.2*0.8cm, 内充满细密光点, 边界清晰, 未见明显血流信号。

左侧面部可见一范围广泛的囊性为主的混合回声团(范围太广无法测量), 厚约0.94cm, 自腮腺上端开始, 部分腮腺组织缺损改变, 向上延伸至颞顶部, 液性区至颞顶部止于帽状腱膜下方, 边界清晰, 未见明显血流信号。

提示:

右侧面部低回声结节--表皮样囊肿首先考虑, 不排除其它可能

左侧面部混合回声团--性质待定, 建议穿刺活检

报告时间: 2026-04-09 13:49

记录员: 徐森胤

检查医师: 徐森胤

徐森胤

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25910305

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肾上腺



检查所见:

左侧肾上腺区探及低回声结节, 大小约 2.2×1.9 cm, 边界清, 形态尚规则, 未见明显异常血流信号。右侧肾上腺区未见明显异常回声团块。

提示:

左侧肾上腺区低回声结节, 请结合临床, 建议进一步检查

报告时间: 2026-04-08 15:35

记录员: 周丽君

检查医师: 周丽君

周丽君

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



微信扫码查看影像

MR检查诊断报告单

姓名	周玉娇	性别	女	年龄	61岁	病人类型	住院
影像号	P0047016	流水号	5023128				
科室	老年病科住院	院区	浙江医院灵隐院区				
临床诊断	甲状腺结节						

检查项目和互认信息（浙江HR）：

胸椎MRI(平扫) (BR37ZYZZZ-00)

影像所见 Image Findings

胸椎生理曲度存在，椎间隙无狭窄。椎体边缘骨质增生，未见明显膨隆及突出性改变。胸髓形态及信号未见异常，椎管无狭窄，椎管内未见异常信号区及占位病变。椎旁软组织无殊。

诊断结果 Diagnosis

胸椎退行性变。

报告医生：罗涛

审核医生：张建军

检查时间：2026-04-07 15:01

报告时间：2026-04-08 14:55

*审核医生签字后有效，本报告仅供临床医师参考。

*浙江医院放射科电话：0571-81595050（灵隐院区）

0571-87377685（三墩院区）



浙江醫院

浙江大学医学院 附属浙江医院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



微信扫码查看影像

MR检查诊断报告单

姓名	周玉娇	性别	女	年龄	61岁	病人类型	住院
影像号	P0047016	流水号	5023129				
科室	老年病科住院	院区	浙江医院灵隐院区				
临床诊断	甲状腺结节						

检查项目和互认信息 (浙江HR) :

颈椎MRI(平扫) (BR30ZYZZZ-00)

影像所见 Image Findings

颈椎曲度变直，C5、6椎体局部融合。颈椎间盘T2WI信号减低，C3/4、C4/5、C6/7椎间盘向周边延伸，相应脊膜囊受压。颈髓无受压、形态及信号无殊。椎管无狭窄。C3/4-C4/5水平棘间韧带可见条状PD fs高信号影。

诊断结果 Diagnosis

C3/4、C4/5、C6/7椎间盘变性、膨出。

C3/4-C4/5水平棘间韧带炎。

颈椎退行性改变，C5、6椎体融合畸形。

报告医生：张晨洋

审核医生：张建军

检查时间：2026-04-07 14:46

报告时间：2026-04-08 09:56

*审核医生签字后有效，本报告仅供临床医师参考。

*浙江医院放射科电话：0571-81595050（灵隐院区）

0571-87377685（三墩院区）



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



微信掃碼查看影像

CT检查诊断报告单

姓名	周玉娇	性别	女	年龄	61岁	病人类型	住院
影像号	P0047016	流水号	5023221				
科室	老年病科住院	院区	浙江医院灵隐院区				
临床诊断	甲状腺结节						

检查项目和互认信息（浙江HR）：

胸部CT(平扫)+BW23ZYZZZ-00

影像所见 Image Findings

双侧胸廓对称，气管居中。双肺血管纹理清晰，双肺见数枚微小结节，长径约2.0-3.0mm，双肺少许条索影。气管支气管走行通畅，未见狭窄及堵塞，纵隔内未见明确肿大淋巴结。双上胸膜局部稍厚。主动脉管壁少许致密影。双侧胸腔未见积液。

诊断结果 Diagnosis

双肺数枚微小结节，较前2023-03-07相仿，建议年度随诊。

双肺少许纤维灶。

双上胸膜局部稍厚。

主动脉少许钙化。

附见：甲状腺右叶结节，肝脏低密度灶。左侧肾上腺结节，请结合专项检查。

报告医生：李振宁

审核医生：李良萍

李良萍

检查时间：2026-04-07 15:51

报告时间：2026-04-08 08:29

*审核医生签字后有效，本报告仅供临床医师参考。

*浙江医院放射科电话：0571-81595050（灵隐院区）

0571-87377685（三墩院区）



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

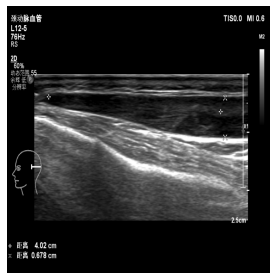
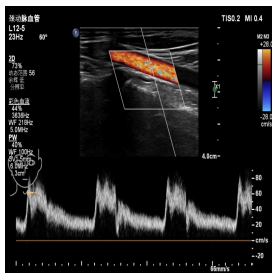
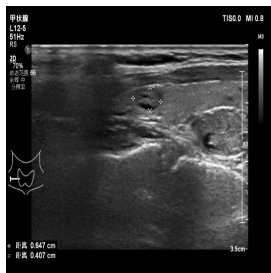
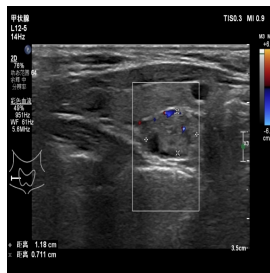
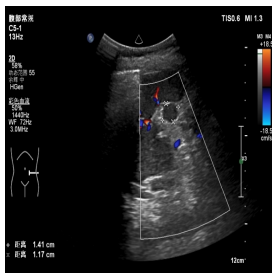
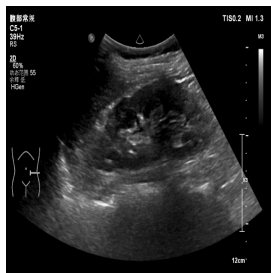
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约1.2*0.8cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约1.4*1.2cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约0.8*0.5cm, 右侧较大约0.6*0.5cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约6.8*0.8cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号： 5010005581 超声号： US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

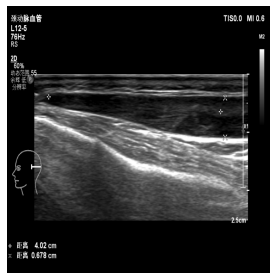
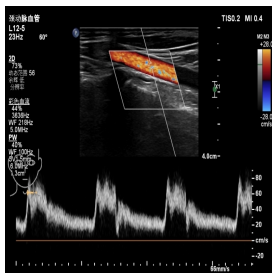
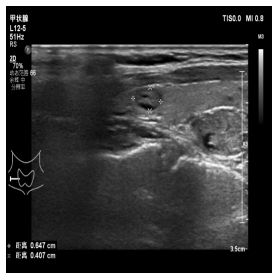
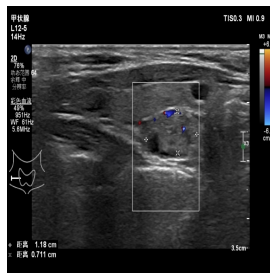
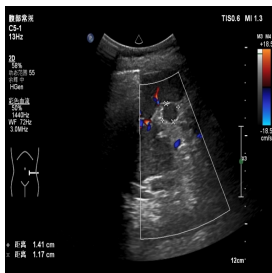
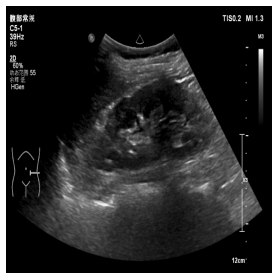
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约 1.2×0.8 cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约 1.4×1.2 cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约 0.8×0.5 cm, 右侧较大约 0.6×0.5 cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约 6.8×0.8 cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号： 5010005581 超声号： US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

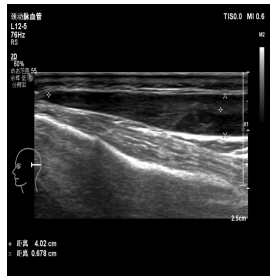
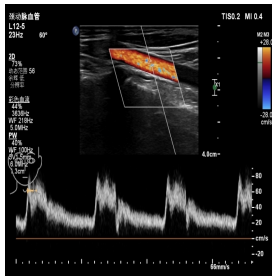
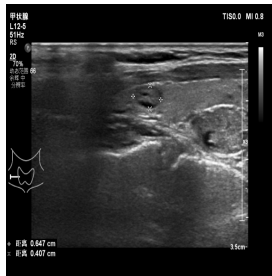
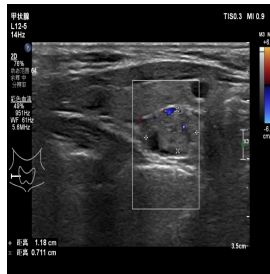
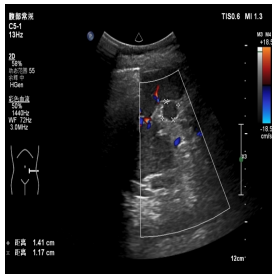
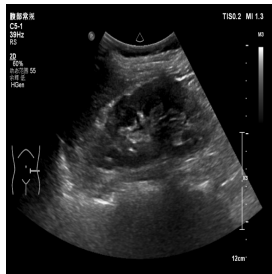
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约 1.2×0.8 cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约 1.4×1.2 cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。

彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约 0.8×0.5 cm, 右侧较大约 0.6×0.5 cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约 6.8×0.8 cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号： 5010005581 超声号： US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

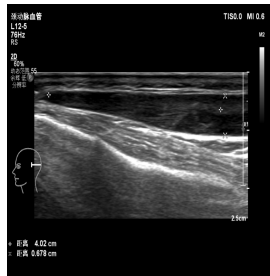
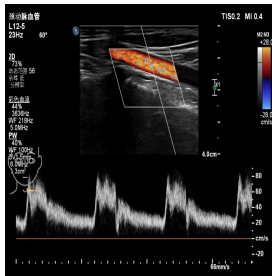
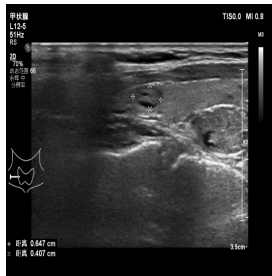
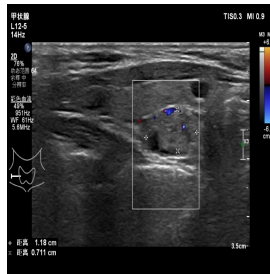
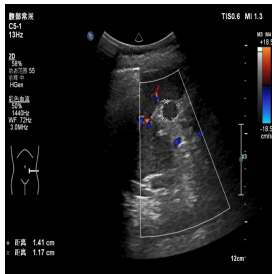
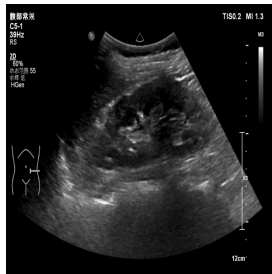
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约 1.2×0.8 cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约 1.4×1.2 cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。

彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约 0.8×0.5 cm, 右侧较大约 0.6×0.5 cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约 6.8×0.8 cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号：5010005581 超声号：US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

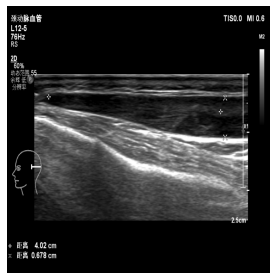
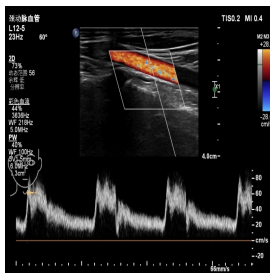
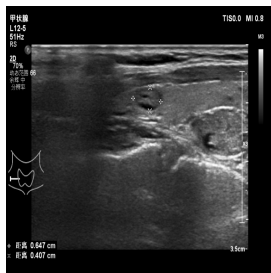
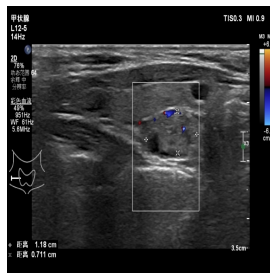
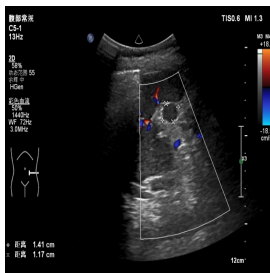
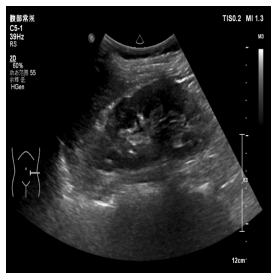
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约1.2*0.8cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约1.4*1.2cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。

彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约0.8*0.5cm, 右侧较大约0.6*0.5cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约6.8*0.8cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号： 5010005581 超声号： US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床

报告时间：2026-04-07 09:25

记录员：莫自楷

检查医师：莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

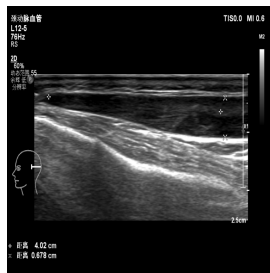
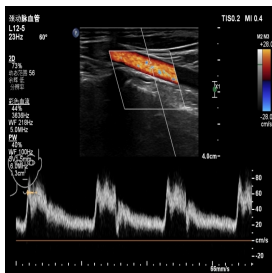
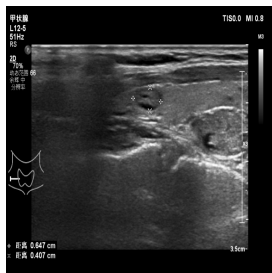
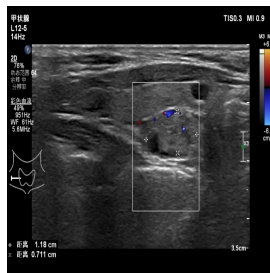
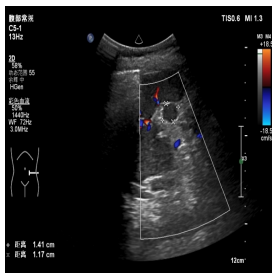
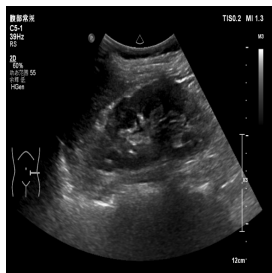
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906399

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 肝、胆、胰、脾, 颈动脉, 甲状腺及甲状腺区淋巴结, 乳腺及其引流区淋巴结, 双肾、输尿管、膀胱, 浅表躯体肿块



检查所见:

肝外形大小正常范围, 表面光滑, 肝内可探及多枚囊性暗区, 较大约1.2*0.8cm, 后伴增强效应。余肝实质回声分布均匀, 血管网清晰, 门静脉主干内径正常范围。

胆囊外形大小正常, 囊壁上见一枚中等回声点附着, 大小约0.3cm, 边界清, 不随体位改变而移动, 后不伴声影。

脾外形大小正常, 轮廓光整, 脾实质回声均匀细腻。于近脾门区探及一枚类圆形低回声灶, 约1.4*1.2cm, 回声同脾实质, 包膜完整, 境界清晰。

双肾形态、大小正常范围, 包膜完整; 皮髓质境界清楚; 集合系统未见明显分离。双肾集合系统内均探及多枚强光点, 较大约0.3cm, 后方伴淡声影。

双侧输尿管未见明显扩张。

膀胱充盈可, 未见明显异常回声。

双侧甲状腺大小, 形态正常, 包膜光滑、清晰完整, 腺体实质回声呈中等细密回声, 分布均匀。彩色多普勒示血流信号正常。双侧甲状腺可见多个结节, 左侧较大约0.8*0.5cm, 右侧较大约0.6*0.5cm, 形态呈椭圆形或圆形, 水平位, 边界清晰, 边缘光整, 周边无声晕, 内部结构呈混合性, 内部无点状强回声, 彩色多普勒示未探及血流信号。

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结回声。

双侧乳腺腺体对称, 回声不均, 结构稍紊乱, 腺体内未见明显结节样回声, 双侧局部导管扩张, 较大内径0.22cm, 内透声可CDFI: 未见明显异常血流信号。

探查患者所示处, 双侧面颊部可及多发囊性回声, 较大位于左侧近颞部, 囊肿位于筋膜层, 形态呈梭形, 边界清, 似可及包膜回声, 内透声欠佳, 大小约6.8*0.8cm, 后方伴增强, CDFI未及内部及周边明

报告时间: 2026-04-07 09:25

记录员: 莫自楷

检查医师: 莫自楷

莫自楷

本报告仅供临床医师参考



超声科诊断报告单

门诊号： 住院号： 5010005581 超声号： US25906399

姓名：周玉娇 性别：女 年龄：61岁 病区：201011002 床号：080015 科室：老年病科住院

检查项目：肝、胆、胰、脾，颈动脉，甲状腺及甲状腺区淋巴结，乳腺及其引流区淋巴结，双肾、输尿管、膀胱，浅表躯体肿块

显示异常血流信号。

附见：右侧甲状腺后方可及 $1.0 \times 1.2 \times 0.8$ cm包块回声，边界清，内回声欠均，CDFI可及散在血流信号。

提示：

肝多发囊肿

胆囊息肉样病变

副脾

双肾小结晶

双侧甲状腺多发结节--TI-RADS 3类

双侧甲状腺区未见明显异常肿大淋巴结

双侧乳腺局部导管扩张--符合BI-RADS 1类

面颊部皮下囊性回声，请结合临床

附见：右侧甲状腺后方低回声团，甲状旁腺瘤？，请结合临床



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25908087

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 双下肢动脉, 双下肢静脉



检查所见:

双侧下肢股、腘动脉、胫后动脉内径正常, 血流通畅。双侧股动脉、腘动脉、胫后动脉内可见强回声斑, 长径约0.1-0.2cm, 后方不伴声影。

双侧股静脉、腘静脉、胫后静脉显示可, 管腔内未见明显异常回声, 血流通畅。左侧肌间静脉管径增宽, 内见实性回声充填, 范围约1.53*0.34cm。CDFI: 管腔内未探及明显血流信号。

提示:

双侧下肢动脉多发细小斑块形成

左侧肌间静脉血栓形成, [建议血管外科会诊](#)

报告时间: 2026-04-07 16:10

记录员: 林莹莹

检查医师: 林莹莹

林莹莹

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25908087

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 双下肢动脉, 双下肢静脉



检查所见:

双侧下肢股、腘动脉、胫后动脉内径正常, 血流通畅。双侧股动脉、腘动脉、胫后动脉内可见强回声斑, 长径约0.1-0.2cm, 后方不伴声影。

双侧股静脉、腘静脉、胫后静脉显示可, 管腔内未见明显异常回声, 血流通畅。左侧肌间静脉管径增宽, 内见实性回声充填, 范围约1.53*0.34cm。CDFI: 管腔内未探及明显血流信号。

提示:

双侧下肢动脉多发细小斑块形成

左侧肌间静脉血栓形成, [建议血管外科会诊](#)

报告时间: 2026-04-07 16:10

记录员: 林莹莹

检查医师: 林莹莹

林莹莹

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25908087

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 双下肢动脉, 双下肢静脉



检查所见:

双侧下肢股、腘动脉、胫后动脉内径正常, 血流通畅。双侧股动脉、腘动脉、胫后动脉内可见强回声斑, 长径约0.1-0.2cm, 后方不伴声影。

双侧股静脉、腘静脉、胫后静脉显示可, 管腔内未见明显异常回声, 血流通畅。左侧肌间静脉管径增宽, 内见实性回声充填, 范围约1.53*0.34cm。CDFI: 管腔内未探及明显血流信号。

提示:

双侧下肢动脉多发细小斑块形成

左侧肌间静脉血栓形成, [建议血管外科会诊](#)

报告时间: 2026-04-07 16:10

记录员: 林莹莹

检查医师: 林莹莹

林莹莹

本报告仅供临床医师参考



浙江醫院

浙江大學醫學院 附屬浙江醫院

AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



微信扫码查看影像

OT检查诊断报告单

姓名	周玉娇	性别	女	年龄	61岁	病人类型	住院
影像号	P0047016	流水号	5021963				
科室	老年病科住院	院区	浙江医院灵隐院区				
临床诊断	甲状腺结节						

检查项目和互认信息（浙江HR）：

双（多）能X线检测（骨密度）

影像所见 Image Findings

骨密度疏松

诊断结果 Diagnosis

骨密度疏松，请结合临床。

报告医生：周华狄

审核医生：卢艳

检查时间：2026-04-07 10:08

报告时间：2026-04-07 10:17

*审核医生签字后有效，本报告仅供临床医师参考。

*浙江医院放射科电话：0571-81595050（灵隐院区）

0571-87377685（三墩院区）



浙江医院

浙江大学医学院 附属浙江医院

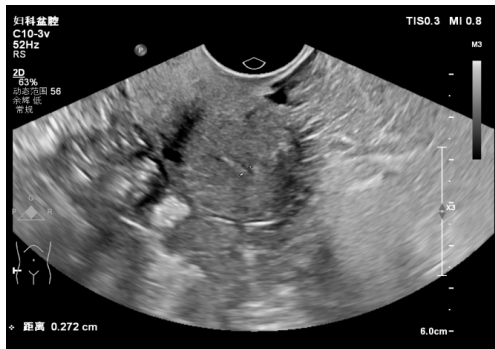
AFFILIATED ZHEJIANG HOSPITAL, ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

超声科诊断报告单

门诊号: 住院号: 5010005581 超声号: US25906400

姓名: 周玉娇 性别: 女 年龄: 61岁 病区: 201011002 床号: 080015 科室: 老年病科住院

检查项目: 经阴道检查(子宫、附件)



检查所见:

经阴道探查:

子宫后位, 外形萎缩, 宫腔线清, 内膜厚约0.27cm, 肌层回声均匀, 未见明显占位灶。
双卵巢未显示, 双附件区未及异常包块。
子宫直肠窝内未见明显游离液性暗区。

提示:

子宫萎缩

报告时间: 2026-04-07 09:41

记录员: 张新捧

检查医师: 张新捧

张新捧

本报告仅供临床医师参考